

Examens préinterventionnels systématiques

Examens cardiologiques & respiratoires



Champ : prescription des examens complémentaires **préinterventionnels systématiques** — réalisés en routine, en dehors de signes d'appel anamnestiques ou cliniques, avant une intervention chirurgicale ou une procédure non chirurgicale sous anesthésie. **Exclut** les examens spécifiques à l'acte ou à la pathologie du patient (ex. EFR avant résection pulmonaire), la chirurgie cardiaque/de résection pulmonaire/intracrânienne, la médecine préventive, et les nouveau-nés (0-28 jours). Actualisation SFAR 2012 des recommandations Anaes de 1998, validée par 14 sociétés savantes. Stratification selon le **type de chirurgie** (risque cardiaque ACC/AHA : faible <1 %, intermédiaire 1-5 %, élevé >5 % — Annexe A) et la **classe ASA** du patient.

Méthodologie GRADE (même schéma que le reste du corpus) : Grade 1+/1- (forte, « il faut faire/ne pas faire ») ; Grade 2+/2- (faible, « il est possible de faire/ne pas faire »). **Vérfié par grep exhaustif** : 38 recommandations tagués (14× 1+, 14× 1-, 9× 2+, 1× 2-). **Disclosure** : la source omet le signe +/- sur 13 de ces 38 tags (elle écrit juste « GRADE 1 » ou « GRADE 2 ») ; le signe est ici résolu à partir du sens univoque de chaque phrase (« il est recommandé de **ne pas** prescrire... » = négatif, jamais le niveau (1 vs 2, toujours explicite) — cohérent avec les tags « GRADE 1- » explicitement signés ailleurs dans ce même document pour des recommandations négatives strictement analogues.

1 — Examens cardiologiques (ECG, échographie)

Réf.	Recommandation (texte condensé, fidèle à la source)	Grade
R1	ECG de repos — quel que soit l'âge : ne pas prescrire un nouvel ECG si un tracé de moins de 12 mois est disponible sans modification clinique ; ne pas prescrire un ECG pour une intervention mineure.	1-
R1	ECG de repos — avant 65 ans : ne pas prescrire un ECG 12 dérivation avant une intervention à risque intermédiaire/élevé (sauf artérielle) en l'absence de signes d'appel, FDR ou pathologie cardiovasculaire.	1-
R1	ECG de repos — après 65 ans : il faut probablement prescrire un ECG 12 dérivation avant toute intervention à risque élevé/intermédiaire, même sans signe clinique, FDR ni pathologie cardiovasculaire.	2+
R1	Échocardiographie transthoracique : ne pas prescrire de façon systématique une échocardiographie de repos préinterventionnelle.	1-
R1	Limiter les indications d'échocardiographie préinterventionnelle aux sous-groupes bénéficiaires : patients symptomatiques (dyspnée, insuffisance cardiaque inconnue/aggravée, souffle systolique non connu, suspicion d'HTAP).	2+

2 — Examens respiratoires (radio thorax, gaz du sang, EFR)

Réf.	Recommandation (texte condensé, fidèle à la source)	Grade
R2	Ne pas prescrire de manière systématique une radiographie de thorax préinterventionnelle en chirurgie non cardiothoracique, quel que soit l'âge, sauf pathologie cardiopulmonaire évolutive/aiguë.	1-
R2	Ne pas prescrire de manière systématique des gaz du sang artériels préinterventionnels en chirurgie non cardiothoracique, quel que soit l'âge, sauf pathologie pulmonaire évolutive/aiguë.	1-
R2	Ne pas prescrire de manière systématique des EFR préinterventionnelles en chirurgie non cardiothoracique, quel que soit l'âge, sauf pathologie pulmonaire évolutive/aiguë.	1-

3 — Examens d'hémostase (TP, TCA, plaquettes)

Réf.	Recommandation (texte condensé, fidèle à la source)	Grade
R3	Évaluer le risque hémorragique d'après l'anamnèse personnelle/familiale de diathèse hémorragique et l'examen physique.	1+
R3	Utiliser probablement un questionnaire standardisé de recherche de manifestations hémorragiques pour l'anamnèse.	2+

Examens préinterventionnels systématiques

Hémostase, hémogramme & immunohématologie



Réf.	Recommandation (texte condensé, fidèle à la source)	Grade
R3	Ne pas prescrire de façon systématique un bilan d'hémostase si l'anamnèse/examen clinique ne fait pas suspecter un trouble — quel que soit le grade ASA, le type d'intervention et l'âge (hors enfants n'ayant pas acquis la marche).	1-
R3	Ne pas prescrire de façon systématique un bilan d'hémostase si l'anamnèse/examen clinique ne fait pas suspecter un trouble — quel que soit le type d'anesthésie (générale, neuraxiale, blocs périphériques/combinées), y compris en obstétrique.	1-
R3	Demander un avis spécialisé en cas d'anamnèse de diathèse hémorragique évocatrice d'un trouble de l'hémostase.	1+
R3	Chez l'enfant n'ayant pas acquis la marche : prescrire probablement un TCA et une numération plaquettaire (dépistage de pathologies constitutionnelles, ex. hémophilie).	2+
R3	Chez l'adulte non interrogeable : prescrire probablement un TP, un TCA et une numération plaquettaire (pathologies constitutionnelles ou acquises).	2+

4 — Hémogramme

Réf.	Recommandation (texte condensé, fidèle à la source)	Grade
R4	Intervention à risque mineur, quel que soit l'âge : ne pas prescrire un hémogramme avant l'acte.	1-
R4	Intervention à risque intermédiaire ou élevé, quel que soit l'âge : prescrire un hémogramme avant l'acte (caractère pronostique, stratégie transfusionnelle).	1+

5 — Examens immunohématologiques (groupe sanguin, RAI)

Réf.	Recommandation (texte condensé, fidèle à la source)	Grade
R5	Risque de transfusion/saignement nul à faible : ne pas prescrire de groupage sanguin ni de RAI.	1-
R5	Risque de transfusion intermédiaire/élevé ou de saignement important : prescrire un groupage sanguin et une RAI.	1+
R5	Disposer des examens IH et de leurs résultats avant l'intervention en cas de risque de saignement important (check-list « sécurité au bloc opératoire »).	1+
R5	Disposer des examens IH et de leurs résultats avant l'intervention en cas de risque de transfusion intermédiaire/élevé.	1+
R5	S'assurer probablement que les examens IH soient disponibles avec leurs résultats lors de la visite préanesthésique.	2+
R5	Prolonger la durée de validité de la RAI négative de 3 à 21 jours si l'absence de circonstances immunisantes (transfusion, grossesse, greffe) a été vérifiée dans les 6 mois précédents.	1+

6 — Examens biochimiques

Réf.	Recommandation (texte condensé, fidèle à la source)	Grade
R6	Ne pas prescrire d'examen biochimique sanguin préinterventionnel systématique, en dehors de signes d'appel, en chirurgie mineure.	1-
R6	Évaluer probablement la fonction rénale (débit de filtration glomérulaire) préopératoire chez les patients à risque devant bénéficier d'une chirurgie intermédiaire ou majeure.	2+
R6	Ne pas prescrire d'examen biochimique urinaire systématique, quel que soit l'âge, quel que soit le type de chirurgie.	1-

7 — Femme enceinte en prépartum



Réf.	Recommandation (texte condensé, fidèle à la source)	Grade
R7	Ne pas prescrire un bilan systématique d'hémostase (TQ, TCA, fibrinogène, plaquettes) dans le cadre d'une grossesse normale sans élément anamnestique/clinique évocateur, y compris avant une ALR périnéale.	1-
R7	Réévaluer la normalité de la grossesse de façon répétée, notamment à l'arrivée en salle de naissance par l'équipe obstétricale, et transmettre à l'anesthésiste.	1+
R7	En présence de situations à risque hémorragique dépistées avant la naissance (ATCD HPP, HELLP, hématome rétroplacentaire, MFIU, anomalie d'insertion placentaire, grossesse gémellaire, utérus cicatriciel, chorioamniotite, trouble d'hémostase connu), disposer d'une RAI de moins de 3 jours.	1+
R7	Dans le cadre d'une césarienne programmée, disposer d'une RAI de moins de 3 jours.	1+

8 — Test de grossesse

Réf.	Recommandation (texte condensé, fidèle à la source)	Grade
R8	Poser la question à toute femme en âge de procréer sur sa méthode de contraception et une possibilité de grossesse, avant tout acte nécessitant une anesthésie.	1+
R8	Si possibilité de grossesse à l'interrogatoire : prescrire un dosage plasmatique des bHCG après consentement de la patiente.	1+
R8	Si bHCG plasmatiques positifs : reporter l'intervention chaque fois que possible.	1+

9 — Dépistage infectieux (ECBU)

Réf.	Recommandation (texte condensé, fidèle à la source)	Grade
R9	Chirurgie urologique (plaie opératoire en contact avec l'urine, y compris endoscopique) : réaliser systématiquement un ECBU préopératoire.	1+
R9	Hors chirurgie urologique, patients avec facteur de risque d'infection urinaire et chirurgie à risque fort (prolapsus/incontinence gynécologique, orthopédie prothétique) : réaliser probablement un ECBU préopératoire systématique.	2+
R9	Patients sans facteur de risque d'IU, chirurgie à risque fort : réaliser probablement une bandelette urinaire (BU), complétée par un ECBU si positive (nitrites/leucocyte-estérase).	2+
R9	Chirurgie à risque faible de complication liée à l'IU, patients sans facteur de risque : ne pas pratiquer probablement d'analyse d'urine (BU ou ECBU).	2-

Tableau 1 — Indication de l'analyse d'urine dans le cadre du bilan préopératoire

Chirurgie	Risque élevé IU/CU (symptomatologie IU, diabète, âge physio-avancé, institution, cathétérisme prolongé)	Risque bas IU/CU (absence de FDR)
Chirurgie des voies urinaires	ECBU systématique	ECBU systématique
Orthopédie prothétique / gynécologie prolapsus-incontinence	ECBU systématique	BU puis ECBU si positive
Autres chirurgies (orthopédie sans matériel, gynécologie hors prolapsus/incontinence)	BU puis ECBU si positive	Rien

Synthèse & Annexe A — Stratification du risque



Tableau 2 — Prescription des examens complémentaires selon le risque patient/intervention

	Intervention à risque faible	Intervention à risque intermédiaire ou élevé
Patient ASA I ou II	Pas d'examens complémentaires systématiques	Prescription en fonction du risque opératoire
Patient ASA III ou IV	Pas d'examens complémentaires systématiques	Prescription en fonction de la pathologie du patient et du risque opératoire

Annexe A — Stratification du risque cardiaque pour la chirurgie non cardiaque (ACC/AHA)

Stratification du risque (décès + infarctus du myocarde)	Exemples d'intervention
Élevé (> 5 %)	Chirurgie aortique ou autre chirurgie vasculaire majeure, chirurgie vasculaire périphérique
Intermédiaire (1-5 %)	Chirurgie intrapéritonéale ou intrathoracique, endartériectomie carotidienne, chirurgie de la tête et du cou, chirurgie orthopédique majeure, chirurgie de prostate
Faible (< 1 %)	Procédures endoscopiques, chirurgie superficielle, chirurgie de la cataracte, chirurgie mammaire, chirurgie ambulatoire

Sources et traçabilité

Document source : « Examens préinterventionnels systématiques » — Recommandations formalisées d'experts, SFAR, 2012 (Ann Fr Anesth Reanim 2012;31:752-763). Auteurs : S. Molliex, S. Pierre, C. Bléry, E. Marret, H. Beloeil. Actualisation des recommandations Anaes de 1998, à partir d'une analyse systématique de la littérature 2001-2011 par 30 experts. Validé par l'AFC, l'AFU, le CNGOF, l'EFS, la SCGP, la SFC, la SFCD, le GEHT, la SF2H, la SOFOP, la SFORL, la SFR-FRI, la SFSCMF et la SPLF.

Méthodologie : GRADE — 38 recommandations taguées (14× 1+, 14× 1-, 9× 2+, 1× 2-), 13 d'entre elles avec un signe +/- résolu à partir du sens univoque de la phrase (voir disclosure méthodologique en page 1).

Couverture : cette fiche reprend l'intégralité des 9 recommandations (examens cardiologiques, respiratoires, hémostase, hémogramme, immunohématologiques, biochimiques, femme enceinte en prépartum, test de grossesse, dépistage infectieux), le tableau 1 (indications ECBU/BU), le tableau 2 (synthèse ASA × risque chirurgical) et l'annexe A (stratification du risque cardiaque ACC/AHA). Comité d'organisation, groupe de travail et références bibliographiques ne sont pas retranscrits (sans contenu clinique).

Avertissement — document de 2012 : ce document est une fiche de synthèse indépendante, produite pour un usage d'aide-mémoire. Elle reprend l'intégralité des recommandations du texte source, mais ne remplace pas le texte intégral (argumentaire complet) et n'est ni éditée ni validée par la SFAR. La prescription des examens complémentaires préinterventionnels ne se substitue en aucun cas à l'interrogatoire et à l'examen clinique du patient.